

Razonamiento clínico — Hombro

bodyPart: shoulder · entry: sh_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 21

Entrada alternativa por test del informe

- **neer** → sh_neer
- **hawkins-kennedy** → sh_hawkins
- **jobe-empty-can** → sh_jobes
- **apprehension** → sh_apprehension
- **drop-arm** → sh_drop_arm
- **painful-arc** → sh_painful_arc
- **speed** → sh_speed
- **cross-body** → sh_cross_body

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Hombro — árbol maestro Physioguide

id: sh_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → cervical si procede → trauma/luxación → localización exacta → rama (RCRSP / anterior / AC / inestabilidad) → cluster → diferencial → coexistencia. Nunca Neer = pinzamiento confirmado.

Hipótesis:

- **Enrutar por mecanismo y localización** (alta) — Luxación/«se sale» → inestabilidad. Lateral → RCRSP. Anterior → bíceps. Superior → AC. Cuello/hormigueo → cervical.
- **Permitir patologías coexistentes** (media) — RCRSP + AC, manguito + cervical, bíceps + RCRSP son válidas.
→ Continúa en: **sh_master_trauma_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Mecanismo de trauma o inestabilidad dominante?

id: sh_master_trauma_gate

testId: route-shoulder-trauma

Descripción: Luxación, subluxación, «se sale», caída FOOSH o deformidad → rama inestabilidad/trauma. Si es overhead/sobreuso sin luxación, continúa por localización.

Procedimiento: Enrutado clínico (no es un test físico).

Evidencia: Aprensión = miedo a que se salga, no solo dolor. Cluster Farber/Hegedus.

- **Positivo / Sí:** Luxación / «se sale» / trauma dominante → **sh_route_instability**
- **Negativo / No:** Sin trauma/inestabilidad dominante → **sh_loc_lateral**

3. [CONCLUSIÓN] Compatible con inestabilidad / trauma de hombro

id: sh_route_instability

Resumen: Historia de luxación/«se sale» o trauma dominante. Aprensión (miedo) apoya; dolor solo no confirma. Cribar fractura y manguito traumático si >40 años + debilidad.

Hipótesis:

- **Inestabilidad anterior** (alta) — Luxación/ABD-RE + aprensión.

- **Rotura traumática de manguito** (media) — Trauma + debilidad franca (esp. edad >40).
 - **AC / fractura** (media) — Caída sobre punta o FOOSH.
- Continúa en: **sh_apprehension**

4. [TEST / GATE] ¿El dolor es lateral / anterolateral?

id: sh_loc_lateral

testId: route-shoulder-lateral

Descripción: Cara lateral, deltoides o anterolateral con elevación → rama RCRSP/manguito. Si no, anterior / AC / posterior.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

Evidencia: RCRSP en cluster; no pinzamiento confirmado (Lewis; Hegedus).

→ **Positivo / Sí:** Lateral / deltoides / anterolateral → **sh_rcrsp_cluster**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **sh_loc_anterior**

5. [TEST / GATE] Apprehension / Relocation

id: sh_apprehension

testId: apprehension

Descripción: Abducción + rotación externa progresiva. Positivo si aprensión; relocation al presionar humeral anterior.

Procedimiento: Abducción + rotación externa progresiva. Positivo si aprensión; relocation al presionar humeral anterior.

Evidencia: Farber JBS 2006: aprensión (miedo a que se salga) > dolor solo. Relocation refuerza. Historia de luxación pesa mucho.

→ **Positivo / Sí:** Miedo / aprensión de que se salga → **sh_instability**

→ **Negativo / No:** Solo dolor sin miedo → **sh_painful_arc**

6. [CONCLUSIÓN] Compatible con RCRSP / irritación del manguito

id: sh_rcrsp_cluster

Resumen: Dolor lateral/anterolateral + elevación + arco/Neer/Hawkins familiar. No «pinzamiento confirmado». Si debilidad + drop arm → rotura importante ↑. Si PROM limitado global → capsulitis.

Hipótesis:

- **RCRSP / tendinopatía del manguito** (alta) — Cluster elevación + dolor familiar sin debilidad franca.
- **Rotura importante de manguito** (media) — Debilidad + drop arm / Jobe débil.
- **Capsulitis / rigid shoulder** (media) — Limitación activa y pasiva global.

→ Continúa en: **sh_neer**

7. [TEST / GATE] ¿El dolor es anterior (surco / delante)?

id: sh_loc_anterior

testId: route-shoulder-anterior

Descripción: Parte delantera o surco bicipital → bíceps/anterior. Speed/Yergason no confirman SLAP.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

→ **Positivo / Sí:** Parte delantera / surco bicipital → **sh_anterior_cluster**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **sh_loc_superior**

8. [CONCLUSIÓN] Compatible con inestabilidad glenohumeral anterior

id: sh_instability

Resumen: Aprensión (miedo) ± relocation. Dolor sin aprensión ≠ inestabilidad.

Hipótesis:

- **Inestabilidad anterior** (alta) — Aprensión + historia de luxación/ABD-RE.
→ Nudo terminal (fin de rama).

9. [TEST / GATE] Arco doloroso

id: sh_painful_arc

testId: painful-arc

Descripción: Abducción activa/pasiva observando dolor entre ~60° y 120°.

Procedimiento: Abducción activa/pasiva observando dolor entre ~60° y 120°.

Evidencia: Arco medio (~60–120°) → RCRSP en cluster (Park/Michener). Dolor solo al final + cruzar pecho → AC.

→ **Positivo / Sí:** Arco 60–120° familiar → **sh_rcrsp_cluster**

→ **Negativo / No:** Sin arco típico → **sh_posterior_cervical**

10. [TEST / GATE] Test de Neer

id: sh_neer

testId: neer

Descripción: Estabilizar escápula y elevar pasivamente el brazo en flexión forzando acercamiento acromio-humeral.

Procedimiento: Estabilizar escápula y elevar pasivamente el brazo en flexión forzando acercamiento acromio-humeral.

Evidencia: Hegedus BJSM 2008/2012: poca utilidad aislado. Cluster RCRSP (Lewis); no confirma pinzamiento.

→ **Positivo / Sí:** Dolor anterolateral familiar → **sh_rcrsp_cluster**

→ **Negativo / No:** Neer no reproduce el dolor habitual → **sh_hawkins**

11. [CONCLUSIÓN] Compatible con dolor anterior / bíceps

id: sh_anterior_cluster

Resumen: Surco bicipital + Speed/Yergason familiar → bíceps ↑. No SLAP automático. Cribado RCRSP e inestabilidad.

Hipótesis:

- **Tendinopatía / irritación del bíceps largo** (alta) — Surco + provocación familiar.
 - **RCRSP con componente anterior** (media) — Coexistencia frecuente.
- Continúa en: **sh_speed**

12. [TEST / GATE] ¿El dolor es superior (AC / clavícula)?

id: sh_loc_superior

testId: route-shoulder-ac

Descripción: Puede señalar la puntita con un dedo + cross-body → AC. Si es posterior/escapular o cuello → referido/cervical.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

→ **Positivo / Sí:** Punta / clavícula / AC → **sh_ac_cluster**

→ **Negativo / No:** Posterior / escapular / cuello / difuso → **sh_posterior_cervical**

13. [CONCLUSIÓN] Posterior / escapular — cribado cervical y local

id: sh_posterior_cervical

Resumen: Dolor posterior o escapular: valorar referido cervical, disfunción escapular y manguito posterior. Spurling negativo no excluye cuello.

Hipótesis:

- **Dolor referido cervical** (alta) — Cuello, hormigueo o tests locales pobres.
 - **Sobrecarga posterior / escapular** (media) — Sin patrón cervical claro.
- Nudo terminal (fin de rama).

14. [TEST / GATE] Hawkins-Kennedy

id: sh_hawkins

testId: hawkins-kennedy

Descripción: Flexión de hombro 90° y rotación interna forzada del antebrazo.

Procedimiento: Flexión de hombro 90° y rotación interna forzada del antebrazo.

Evidencia: Hegedus BJSM: inespecífico aislado. Michener 2009: mejor en combinación con otros tests de manguito.

→ **Positivo / Sí:** Hawkins familiar → **sh_rcrsp_cluster**

→ **Negativo / No:** Hawkins no familiar → **sh_jobc**

15. [TEST / GATE] Test de Speed

id: sh_speed

testId: speed

Descripción: Codo extendido, antebrazo supinado; flexión de hombro resistida (~60–90°). Dolor en surco bicipital.

Procedimiento: Codo extendido, antebrazo supinado; flexión de hombro resistida (~60–90°). Dolor en surco bicipital.

Evidencia: Dolor en surco bicipital → bíceps. Hegedus BJSM: NO confirma SLAP.

→ **Positivo / Sí:** Dolor en surco familiar → **sh_anterior_cluster**

→ **Negativo / No:** Speed no familiar → **sh_rcrsp_cluster**

16. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología acromioclavicular

id: sh_ac_cluster

Resumen: Dolor en la AC + cross-body familiar. No confundir con RCRSP deltoideo.

Hipótesis:

· Irritación / esguince / OA AC (alta) — Localización puntual + aducción horizontal.

→ Continúa en: **sh_cross_body**

17. [TEST / GATE] Jobe / Empty can

id: sh_jobc

testId: jobc-empty-can

Descripción: Abducción 90° en plano escapular, pulgar hacia abajo. Resistencia a la abducción.

Procedimiento: Abducción 90° en plano escapular, pulgar hacia abajo. Resistencia a la abducción.

Evidencia: Dolor → supraespinoso/RCRSP. Debilidad + drop arm → rotura ↑ (dolor puede imitar debilidad). Hegedus BJSM.

→ **Positivo / Sí:** Debilidad franca o dolor intenso → **sh_cuff_weak**

→ **Negativo / No:** Jobe poco provocativo → **sh_drop_arm**

18. [TEST / GATE] Cross-body / aducción horizontal

id: sh_cross_body

testId: cross-body

Descripción: Aducción horizontal del brazo cruzando por delante del pecho hacia el hombro contralateral. Registrar si el dolor es en la puntita AC y familiar.

Procedimiento: Aducción horizontal del brazo cruzando por delante del pecho hacia el hombro contralateral. Registrar si el dolor es en la puntita AC y familiar.

Evidencia: Chronopoulos / Walton: contribuye al diferencial AC. Positivo en la punta ≠ manguito; no inventa grado de separación AC.

→ **Positivo / Sí:** Dolor en la puntita AC → **sh_ac_cluster**

→ **Negativo / No:** Dolor más deltoideo / no AC → **sh_rcrsp_cluster**

19. [CONCLUSIÓN] Compatible con afectación del manguito (valorar rotura si debilidad)

id: sh_cuff_weak

Resumen: Jobe débil o muy doloroso apoya manguito; debilidad franca + drop arm eleva rotura importante. No inventar tamaño.

Hipótesis:

- **RCRSP / supraespinoso** (alta) — Dolor o debilidad en empty can.
 - **Rotura importante de manguito** (media) — Debilidad clara vs contralateral.
- Continúa en: **sh_drop_arm**

20. [TEST / GATE] Drop arm

id: sh_drop_arm

testId: drop-arm

Descripción: Abducción activa máxima y descenso controlado del brazo.

Procedimiento: Abducción activa máxima y descenso controlado del brazo.

Evidencia: Caída/no control al bajar → rotura importante ↑. Más específico que sensible en síntesis (Hegedus). No indica tamaño.

- **Positivo / Sí:** No controla el descenso → **sh_cuff_tear**
- **Negativo / No:** Descenso controlado → **sh_apprehension**

21. [CONCLUSIÓN] Compatible con rotura importante de manguito

id: sh_cuff_tear

Resumen: Drop arm + debilidad apoyan rotura sustancial (clínica). Imagen si déficit persiste. No completa vs parcial automática.

Hipótesis:

- **Rotura importante del manguito** (alta) — Incapacidad para controlar el descenso + debilidad.
- Nodo terminal (fin de rama).